



3

57. ÅRGANG | 03 • 2020

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Tema

Artikler fra forskning og praksis

PPT nr. 3-2020

Tvivl og mod

– uærbødighed overfor etablerede forforståelser

Af Nicola Nyhave

Tvivl og mod

– uærbødighed overfor etablerede forforståelser



Indledning og problemformulering

Følgende artikel bygger bl.a. på erfaringer fra 10 års arbejde som psykolog i en kommunal børne- og familieafdeling. Den tager udgangspunkt i en oplevelse af, at vi lever i en tid, hvor vi ofte bliver optagede af at finde enkle og endegyldige svar og løsninger på livets udfordringer. Denne optagethed kan resultere i, at vi får reduceret og adskilt fænomener (og meget andet) på måder, som bliver uhensigtsmæssige for os. Hvilket i sidste ende kan komme til at modarbejde vore egne ønsker og mål, eksempelvis ønsket om at afhjælpe menneskelig lidelse. Artiklens hovedspørgsmål er: Hvilken betydning kan det få, når reducerende forforståelser eller tilgange bliver meget dominerende, og den foretrukne viden¹ ikke levner plads til alternative forklaringer/teorier, nysgerrighed og tvivl?

Af Nicola Nyhave, autoriseret psykolog og specialist i børnepsykologi

Denne problematik bliver i det følgende belyst med udgangspunkt i den psykiske diagnose ADHD. Der har generelt været en betydelig stigning i antallet af børn og unge, som er blevet diagnosticeret med en psykisk lidelse i Danmark i perioden fra 2006-2016. Der er sket en tredobling i antallet af børn og unge, som i perioden er blevet diagnosticeret med ADHD (Sundhedsstyrelsen, 2017). Den aktuelle foretrukne forklaring på ADHD er, at der er en de-

fekt i det enkelte barns neurobiologi², som resulterer i en forøget forekomst af impulsivitet, koncentrationsvanskeligheder og motorisk uro. Den foretrukne forklaring har resulteret i en foretrukken behandlingstilgang – den medicinske. Ved hjælp af bl.a. caseeksempler diskuteres følgende:

Hvad er ulemperne ved et ensidigt fokus på det enkelte menneskes neurobiologi – hvad kommer vi til at overse?

Hvilken betydning kan det få for valget af behandlingstilgang/intervention, når vi bliver meget optage-

1 Foretrukken viden er et begreb, der bruges af psykolog og ph.d. Jørn Nielsen og børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz for at synliggøre, at der ikke findes absolutte sandheder – men forskellig viden som kan vægtes i større eller mindre grad.

2 Denne foretrukne forklaring ses mange steder, eksempelvis hos psykiatrifonden.dk under: "Hvad er ADHD?"

de af muligheden for at kunne dokumentere effekten på gruppeniveau?

Hvilke mulige konsekvenser kan et ensidigt fokus på en medicinsk behandlingstilgang få for det enkelte menneske?

Artiklen tager udgangspunkt i et bio-psyko-socialt og transdisciplinært videnskabssyn³ og afrundes med forslag til anbefalinger på ADHD-området.

Altings forbundethed

Jeg stødte for kort tid siden sammen med en psykologkollega i en diskussion om børn og unges udviklingsmuligheder. Jeg kom i diskussionen med eksempler på børn og unge, som jeg i mit arbejdsliv havde oplevet, havde udvik-

let sig på tidligere uanede måder⁴. Derudover kom jeg med et eksempel fra mit privatliv på et barn, som jeg kender, som nu har et funktionsniveau som mange tidligere havde anset for utænkeligt. Jeg blev mødt med det synspunkt, at det var usagligt at bringe erfaringer fra privatlivet i spil i en faglig diskussion. Dette synspunkt giver mening, hvis man tænker, at menneskelige erfaringer kan rubriceres og adskilles, og at viden fra ét område (arbejdsområdet) er mere gyldig end viden fra et andet (privatlivet). Vi er som psykologer traditionelt skolet i at adskille vores privatliv fra vores faglighed, skønt min egen oplevelse er, at mit arbejdsliv er gennemsyret af mine personlige erfaringer, overbevisninger og holdninger. Denne oplevelse understøttes af den norske professor Per Jensen fra VID universitetet, der i årevis har interesseret sig for, hvordan en terapeuts private oplevelser og holdninger influerer på terapien⁵. Wilson (2012) referer ligeledes til viden, der understøtter, at terapeuter vælger en

3 Dette videnskabssyn ses hos eksempelvis Gregory Bateson, Nora Bateson – og hos Søren Hertz og Jørn Nielsen i deres artikler, bøger og på efteruddannelsen Metalog. Transdisciplinaritet er ikke blot en sammenlægning af viden fra forskellige discipliner, men en tro på at mangeartede perspektiver på et genstandsområde bidrager med mere end summen af de enkelte dele. Dette videnskabssyn indeholder også en insisteren på at biologiske, psykologiske og sociale delelementer spiller sammen – og kan gøre det på udviklingsfremmende måder. Det bygger på teorier om hjernens plasticitet og understreger, at hjernen udvikler sig i kraft af kontekstuelle forhold, i kraft af det sociale samspil i de afgørende relationer. Det er også et videnskabssyn, der lægger vægt på, at det ikke er muligt at beskrive fænomener uafhængigt af den, der beskriver dem. Hvilket bevirker, at der er et fokus på at udforske for forståelser og grundantagelser – en konstant nysgerrighed på, hvad viden er, og hvor det kommer fra. For yderligere information se eksempelvis Montuori (2005) og Metalog.dk.

4 De uanede udviklingsmuligheder er et begreb, som benyttes af Søren Hertz (eksempelvis i Hertz, 2008). Det refererer til de udviklingsmuligheder hos børn og unge, som endnu ikke er synlige. Uanede udviklingsmuligheder må ikke forveksles med uendelige udviklingsmuligheder. Alt er altså ikke muligt, ifølge Hertz – men udvikling er altid en mulighed.

5 Per Jensen har ligeledes interesseret sig for, hvorfor dette område ikke er bedre undersøgt. Han tilskriver det, det han kalder den instrumentalistiske fejlslutning – at metoden bliver betragtet som terapiens virksomme element, og at det som terapeuten selv bringer ind i rummet i form af eksempelvis egne oplevelser og erfaringer betragtes som "støj", som skal elimineres.

terapeutisk retning, der etisk og politisk passer med deres personlige erfaringer – ligesom selv den mest positivtisk orienterede forsker sandsynligvis udvælger sit forskningsområde på baggrund af en teori og en forforståelse, som udspringer af erfaringer opsamlet igennem hele det levede liv (Thuren, 2010). Og altså ikke kun dem der er blevet erhvervet igennem støvede fagbøger eller et mikroskop. Ligesom min faglighed ikke kan adskilles fra mit levede liv – således kan mine tanker, forforståelser og fortolkninger heller ikke adskilles fra de større sammenhænge, jeg indgår i. Dét, jeg i dagligdagen tænker, er mine egne overbevisninger og holdninger, er i virkeligheden et aftryk af de relationer, jeg tidligere har indgået i – og i yderste konsekvens den kulturelle kontekst jeg er indlejret i. Vi forstår verden igennem forforståelser – allerede eksisterende meninger og fordomme, som hjælper os med at skabe orden og mønstre i vores opfattelser af alting (Mosgaard, 2009). Således er den menneskelige oplevelses- og erfaringsverden vævet sammen i komplekse mønstre, som ikke sådan lader sig adskille.

Til trods for det er udsagnet fra kollegaen et lille eksempel på, hvordan mennesker i mange situationer søger mod at adskille og forenkle ting, som i virkeligheden dårligt lader sig adskille og forenkle – og ikke uden et betydeligt tab. Ifølge Gregory Bateson, antropolog og videnskabsmand⁶, er vores tanke

om, at ting i verden kan adskilles, og at vi kan forholde os til dem separat fra den helhed, de indgår i, skyldt i de største problemer i verden (Bateson, 2010). Helt aktuelt kan klimakrisen og biodiversitetskrisen ses som eksempler på dette (Hoffmann, 2019). At vi mennesker i vid udstrækning har tænkt, at vi kunne tilgodese egne interesser og umiddelbare behov uden at forholde os til, hvordan dette ville påvirke den større sammenhæng, vi indgår i, og i sidste ende vores arts fremtidsmuligheder på jorden.

En adskillelse af forskellige fagområder – eksempelvis psykologien, antropologien og lægevidenskaben er en konstruktion, som på sin vis derfor heller ikke er meningsfuld. Man kan forsvare opdelingen med, at man jo ikke kan vide alt, og derfor naturligt må lave en afgrænsning. Problemet opstår, når man tænker, at denne opdeling /afgrænsning eksempelvis må være imellem krop og psyke, og man ikke får øje på, at man ved udelukkende at fokusere på den ene del – aldrig rigtigt kommer til at forstå den. Ting må ses i sammenhæng for at give mening⁷. Nyere forskning i epigenetik fortæller os, at vi ikke kan forudsige ret meget om et menneske ved udelukkende at interessere os for indholdet i generne. Miljømæssige faktorer påvirker, hvilke gener der “tændes” eller “slukkes” – hvilke proteiner der dannes i den enkelte celle, og hvilke egenskaber cellen får

6 Alfonso Montuori beskriver i sin artikel “Gregory Bateson and the Promise of Transdisciplinarity” at Bateson er vanskelig at kategorisere, da han arbejdede transdisciplinært – og således bl.a. arbej-

dede med familierapi, kommunikation, evolutionsteori, dyreadfærd, skizofreni, systemteori og antropologi.

7 At alting er forbundet og således altid må forstås i kontekst, er en central tanke hos Gregory Bateson. Se bl.a. Montuori (2005)

(Ørum-Madsen, 2015). I sidste ende elementer der påvirker alt fra et menneskes fysiske træk til temperament og personlighed. Det ubrydelige bånd imellem krop og psyke bliver også synligt i de såkaldte ACEs (Adverse Childhood Experiences Studies). De viser sammenhængen imellem barndoms-traumer og en forøget risiko for psykiske lidelser og fysiske sygdomme senere i livet. Dette inkluderer bl.a. en forøget risiko for kræft og diabetes, som ikke kan forklares med forskelle i livsførsel/risikoadfærd (Harris, 2014). Oplevelser bliver således til kemiske substanser og fysisk sygdom og væver igen biologi og psykologi sammen i en gordisk knude. Som Alexander den Store forsøger vi mennesker i mange situationer at skære knuden over og finde simple løsninger på komplekse problemer (Bateson, 2016).

De tillokkende kasser

Diagnosesystemet er et oplagt eksempel på menneskets tendens til at reducere kompleksitet og gøre ting simple og overskuelige. Der er mange gode grunde til, at dette bliver attraktivt, særligt i en tid hvor vi er optagede af at kvantificere lidelser og sygdomme med henblik på bl.a. at få et universalt fælles sprog, lave statistik og videnskabelige undersøgelser (WHO, 2016). Derudover er tanken, at en korrekt stillet diagnose kan målrette en behandling – til gavn for det enkelte menneske og samfundet. Bag tanken om, at man kan finde den korrekte diagnose – og at en korrekt diagnosticering leder frem til en lige så korrekt behandling, gemmer der sig en masse forforståelser fra den biomedicinske

verden. Nyrebækkenbetændelse kan eksempelvis ofte påvises ved hjælp af en urinprøve og et symptombillede med feber, smerter i flanken og almen sløjhed – og efterfølgende behandles med antibiotika (Sundhed.dk).

Det er ikke så simpelt med det, som kaldes psykiske lidelser⁸. Til trods for det bliver det ofte de biomedicinske forforståelser, som også her bliver dominerende. En tidlig opsporing, diagnosticering og behandling af ADHD er i en undersøgelse fra Rockwoolfonden blevet forbundet med en betydelig økonomisk gevinst for samfundet (Rockwoolfonden, 2014). Der ses således et rimelig simpelt lineært forhold imellem at opspore ADHD, diagnosticere det og slutteligt behandle det med succes. I Gundersen, Hertz og Nielsens artikel (2016) diskuteres Rockwoolfondens konklusion – og der stilles spørgsmålstegn ved både undersøgelsens design og ved flere af præmisserne for konklusionen, eksempelvis at ADHD er en medfødt tilstand (i stedet for en beskrivelse af symptomer), og at en diagnosticering af ADHD udelukkende rummer positive potentialer. Sådanne forforståelser og mange lignende møder jeg jævnligt både hos borgerne og andre fagpersoner, når jeg eksempelvis arbejder med PPR opgaver.

8 Det er heller ikke altid så enkelt med fysiske sygdomme, da et sygdomsforløb og en behandling også kan påvirkes af eksempelvis psykosociale faktorer. Dette emne behandles bl.a. i kandidatafhandlingen "Psykosociale faktorerers indflydelse på behandlingen af børn og unge med diabetes mellitus", skrevet af Lene Juul Kristensen i 2007.

De endegyldige konklusioner

For et stykke tid siden sad jeg til et tilbagemeldingsmøde med en højt specialiseret psykolog, som havde lavet en udredning af en dreng på 4 år. Hun sluttede sin tilbagemelding med at sige, at hun vurderede, at det ville være en god idé at henvise ham til børnepsykiatrien, så man kunne finde ud af, om det var en reel opmærksomhedsforstyrrelse – eller om årsagen til hans opmærksomhedsproblemer og uro nærmere skulle findes andre steder, eksempelvis i hans præmature fødsel eller i miljømæssige faktorer. En af de forforståelser en sådan udmelding hviler på er, at børnepsykiatrien er et sted, hvor vi kan sende børn hen med henblik på at finde ind til sandheden om deres lidelser eller karaktertræk. Børnepsykiatrien forventes således at kunne give os præcise og utvetydige svar. En anden forforståelse den hviler på er, at børnepsykiatriske diagnoser afspejler virkelige isolerbare tilstande, som optræder uafhængigt af, hvad der ellers er på spil i barnets liv. En sidste forforståelse er, at en sådan afklaring er betydningsfuld.

Reelt er det ikke muligt at vurdere, om en række symptomer (motorisk uro, koncentrationsbesvær og impulsivitet) er tegn på det, mange kalder en neurobiologisk lidelse, ADHD – eller om symptomerne er et udtryk for andre ting. ADHD er ikke en håndgribelig isolerbar tilstand, som hos det enkelte menneske kan ses på en skanning⁹ eller i en blodprøve – eller i en

psykologisk test for den sags skyld. Så denne ønskede skelnen imellem ADHD og “andet” er umulig, uagtet om man tilslutter sig tanken om, at ADHD er en neurobiologisk lidelse eller ej. Som beskrevet er det muligvis også meningsløst at lave denne skelnen, eftersom neurobiologi påvirkes af relationelle oplevelser og miljømæssige faktorer. Så det bliver på mange måder en illusion, når vi forsøger at få endegyldige og afgrænsede svar vedrørende oprindelsen til uro og koncentrationsbesvær.

Derudover er det i nogen grad paradoksalt, at forvente af børnepsykiatrien at de kan afklare årsagsforhold, når selve diagnosesystemet kun i meget begrænset omfang beskæftiger sig med årsager og næsten udelukkende beskæftiger sig med symptomer¹⁰. En diagnostisk afklaring vil i nogle tilfælde blot give os et navn for en række symptomer, en fremtrædelsesform (Hertz, 2017) som vi godt var klar over, at barnet havde i forvejen. Derudover foregår en diagnostisk afklaring ikke i

pocampus) hos børn som er diagnosticeret med ADHD, og børn som ikke opfylder diagnosekriterierne. Hjernestrukturerne hos børn diagnosticeret med ADHD er generelt mindre. Størrelsesforskellen er ikke så markant, at den kan bruges til at diagnosticere ud fra, da der er en naturlig variation i størrelsen af hjernestrukturer. Størrelsesforskellen udlignes med alderen, hvilket støtter teorien om, at hjernen, hos nogle børn af endnu ukendte årsager, udvikles i et langsommere tempo (Se eksempelvis videnskab.dk “ADHD kan muligvis ses i hjernen” fra 16. februar 2017).

¹⁰ Den foretrukne årsagsforklaring bliver dog synlig, når man i ICD 11 klassificerer ADHD som en neurologisk udviklingsforstyrrelse (neurodevelopmental disorder).

⁹ På gruppeniveau er der fundet signifikant forskel på størrelsen af forskellige hjernestrukturer (amygdala, accumbens og hip-

et lufttomt rum. Den påvirkes af mange faktorer – så som hvilke oplysninger der er tilgængelige, og hvem de afgives af, den enkelte fagpersons kompetencer og forforståelser, tilgængelige ressourcer, strømninger i tiden og mange andre ting. En diagnostisk afklaring er altså ikke som et regnestykke, der nydeligt går op – med kun et facit. Selvom en diagnostisk afklaring indeholder både illusioner og paradokser, kan det vel alligevel give god mening at bevæge sig ned af den vej, hvis endemålet bliver hjælp til et menneske, som lider? I de ca. 8 år hvor jeg delte mange af de skitserede forforståelser – og derfor hyppigt henviste børn til børnepsykiatrien oplevede jeg, at endemålet efter en ADHD diagnose næsten uden undtagelse blev en medicinsamtale. En medicinsamtale og efterfølgende medicinering er et positivt endemål, hvis medicinering – som Rockwoolfonden vurderer – udelukkende har positive potentialer. Men har den nu også det?

De reducerede forklaringer

Der er i dag fra Sundhedsstyrelsen kommet en større opmærksomhed på, at medicinering af børn med ADHD kan have langtidsbivirkninger/alvorlige skadevirkninger, vi ikke kender – og at den positive kliniske effekt af medicinen er påvist indenfor en meget begrænset tidsperiode. Der er også en anbefaling om, at man bør starte med at forstå barnets symptomatologi ud fra en helhedsorienteret og systemisk sammenhæng – og at man som udgangspunkt altid bør starte med at afprøve ikke-farmakologisk behandling (Sundhedsstyrelsen, 2018). Men hvem håndhæver disse anbefalinger – og for-

midler den viden, således at den også er tilgængelig i den brede befolkning? Og hvem sikrer, i en tid med knappe ressourcer, at barnet bliver forstået med udgangspunkt i hele sin livssituationen – biologisk, socialt og emotionelt?

Jeg lavede for et stykke tid siden en psykologisk undersøgelse af en ung mand på 16 år. Christian var beskrevet som en almindeligt begavet dreng med omfattende koncentrationsvan-skeligheder, tendens til impulsivitet og nedsat dømmekraft, udfordringer i det sociale felt og en udpræget følsomhed overfor lyde. Hans skoleliv havde været meget usammenhængende siden 3. klasse, hvor der havde været et lærerskifte. Han havde ikke haft et undervisningstilbud i 6 måneder – og inden da havde han flere afbrudte efterskoleforløb bag sig. Han var, ca. et halvt år inden jeg påbegyndte min undersøgelse af ham, blevet diagnosticeret med ADHD og var i medicinsk behandling med Methylphenidat. Det blev klart for mig, i de 2-3 måneder som undersøgelsen løb over, at Christian var meget påvirket af søvnproblemer. Disse havde en stor indflydelse på hans funktionsniveau. Han havde, siden han var lille, været plaget af indsovningsbesvær og hyppige opvågninger. I perioder sov han, ifølge eget og moderens udsagn, slet ikke 1-2 nætter om ugen.

Jeg blev nysgerrig på, hvordan Christians vanskeligheder skulle forstås – og på hvilken måde hans søvnproblemer – og efterfølgende symptomer, diagnose og behandling påvirkede hans muligheder for udvikling. Christian opfyldte diagnosekriterierne for ADHD, fordi han havde massive kon-

centrationsvanskeligheder og var impulsiv og ind imellem kropsligt urolig. Derfor blev han medicineret med Methylphenidat. Koncentrationsvanskeligheder og nedsat dømmekraft er velkendte bivirkninger ved søvnmangel. En meget almindelig bivirkning ved Methylphenidat er søvnløshed. Der synes således at være en situation, hvor man kunne være bekymret for, at søvnløsheden giver symptomer som berettiger til en diagnose, som behandles med medicin, som vedligeholder eller forstærker søvnproblemerne – og således låser drengen fast i en ond cirkel¹¹.

Derudover var det relevant at blive klogere på, hvad der aktuelt påvirkede hans søvn – udover muligvis medicinen. I samtalerne med ham blev det klart, at han var plaget af mange selv-kritiske tanker, som særligt fyldte ved sengetid. Han havde i flere tilfælde, som lille, været overladt til en misbrugende forælder. Han havde mange negative oplevelser med fra sit skoleliv og var bl.a. fortsat påvirket af situationer, hvor han var blevet ekskluderet fra fællesskabet og udskældt af læreren. Han tilbragte dagene med stillesiddende aktiviteter, og så ofte Netflix indtil sent om natten. Hans mor arbejdede på skæve tidspunkter og havde svært ved at hjælpe ham med at opretholde en stabil døgnrytme. Der er således ingen simple forklaringer på, hvad der

spænder ben for denne unge mands udvikling – kun en masse komplekse udfordringer, som kalder på komplekse løsninger.

En diagnosticering med ADHD tilbyder en reduceret forklaring, som ikke tager højde for drengens levede liv, relationelle vilkår og oplevelser. Derfor synes den ikke umiddelbart at være hjælpsom. Og slet ikke hvis den eneste behandling, som drengen og hans familie tilbydes, risikerer at forstærke eller fastholde hans vanskeligheder.

Det er ikke min erfaring at psykiatrien tilbyder, eksempelvis familiebehandling, eller almindeligvis stiller et krav om, at bestemte tiltag skal være afprøvet i en længere periode, før end de henviser til en medicinsamtale. Derudover har kommunerne dårligt råd til at stille med længerevarende familiebehandling eller lign. – og familierne selv har da slet ikke. Så til trods for gode intentioner fra Sundhedsstyrelsen kan man tænke, at resultatet bliver lidt det samme. Hvis medicin er det eneste, der kan tilbydes, ja, så vil der i mange desperate familier være aftagere, som endda vil forsøge at lægge pres på systemet ift. at gøre noget – i betydningen: Ordinere medicin. Særligt hvis den viden om mulige bi- og skadevirkninger og begrænset evidens ikke er almindelig kendt.

Foretrukken viden, magt og evidens

At have viden er ensbetydende med at have magt (Foucault) – men omvendt er det at have magt også ensbetydende med, at man i højere grad kan påvirke, hvilken viden der gøres tilgængelig – eller foretrukken (Nielsen & Hertz,

11 Børn, som får en ADHD diagnose, oplever oftere søvnproblemer end andre børn. Det er fortsat uafklaret, hvordan man skal forstå sammenhængen imellem søvnproblemerne og ADHD diagnosen. Se eksempelvis: Videnskab.dk 6. august 2016: "For-sker: Der er håb i sigte for ADHD-børn og deres familier".

2010). At en viden ikke er foretrukken handler altså ikke nødvendigvis om, at den ikke er lige så gyldig eller sand som den viden, der er foretrukken. Det kan handle om mange ting – trends i tiden, økonomiske interesser, kultur – eller dominerende forforståelser hos dem som har magten til at bestemme, hvilken viden der skal ud i et større forum, og hvilken som skal ned i papirkurven. At kunne udbrede, kontrollere og omskabe viden er flerdobbelt magt (Sommer, 2017). Medicinalindustrien er magtfuld bl.a. fordi den har penge, og kan præge, hvad der forskes i, hvem der forsker i det, og hvilke forskningsresultater der offentliggøres (Warming, 2015). Dertil kommer en implicit magt, som er afledt af det biomedicinske paradigme. Vi har en langvarig forståelse af lægen som en person, der med videnskaben i ryggen tilbyder en gavnlig, forsvarlig og dokumenteret behandling. Vi har således tillid til, at den, der udskriver medicinen til os, vil os det bedste – og har kompetencen til at vurdere, hvad der reelt er det bedste. Derfor må man formode, at mange mennesker vil være tilbøjelige til ukritisk at sige ja, til den medicin lægen ordinerer.

Medicinalindustriens magt er således en medvirkende årsag til, at medicinsk behandling af det vi kalder psykiske lidelser, i mange situationer er blevet og fortsat bliver den foretrukne praksis. Men der er mange andre årsager, bl.a. det attraktive ved at løse komplekse problemer med simple virkemidler, og historiske erfaringer med at medicin kan helbrede tidligere uforklarlige og uhelbredelige sygdomme, som syfilis (Jensen, 2009).

Derudover er der den massive indflydelse fra evidensbevægelsen, eller virkningsdiskursen (Jensen, 2009). Siden 1990'erne, hvor lægegerningen blev anklaget for at være for lidt forankret i forskningen (Ekeland, 2009) og New Public Management tankegangen i de vestlige samfund generelt tog til (Thorgård, 2012), er det blevet ekstremt vigtigt at kunne dokumentere, at den indsats, man laver ift. patienter/klienter/borgere, har en effekt. Det er vigtigt både ud fra et etisk synspunkt – men også ud fra et økonomisk synspunkt. Det skal kunne dokumenteres, at de indsatser, der bevilliges penge til, virker og er effektive (Thorgård, 2012). Dette evidenskrav har spredt sig til mange af livets områder.

Med evidensbevægelsen kom også evidenshierarkiet – en rangordning af hvilke typer af videnskabelige undersøgelser som havde den største sandhedsværdi. Øverst i hierarkiet er RCT-studiet (randomiserede kontrollerede studier). I RCT studiet forsøger man at tilstræbe, at alle deltagerne har de samme karakteristika, for at undgå selektionsbias, hvorefter man tilfældigt opdeler dem i en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. Det eneste, der ideelt set adskiller interventionsgruppen og kontrolgruppen fra hinanden, er den indsats, man ønsker at undersøge. RCT-studiet sikrer den bedst mulige påvisning af et kausalitetsforhold imellem intervention og effekt – og betegnes som "guldstandarden" indenfor forskning. I RCT-studiet fjerner man konteksten og undtagelserne og ser på, om noget har en effekt på gruppeniveau. Selv om der i visse sammenhænge gøres opmærksom på, at man måske

i virkeligheden ikke skal opstille et evidenshierarki på denne måde – men mere burde interessere sig for, hvilke undersøgelser der reelt kan sige noget om det, vi gerne vil have svar på – så står RCT fortsat som en særlig stærk form for evidens (Thorgård, 2012). RCT-studiet egner sig godt til at undersøge, om et bestemt medicinsk præparat har en effekt. Men hvordan ser det ud med andre interventionsformer?

Tæller det, hvis det ikke kan tælles?

Hvis man tænker, at terapeutiske interventioner ligesom medicin har en virksom ingrediens, som er uafhængig af konteksten og kan sættes på formel og reproduceres, så er det rimeligt at undersøge effekten af både medicin og terapeutiske interventioner på samme vilkår – ud fra den samme “guldstandard”. Tanken om denne virksomme effekt finder man bag manualbaserede interventioner, eksempelvis forældretræningsprogrammer. Evidensen for brug af disse forældretræningsprogrammer ift. ADHD kernesymptomer er samlet set meget lav – ligesom den er for andre ikke-farmakologiske interventioner (Sundhedsstyrelsen, 2018). Men hvad nu hvis terapeutiske interventioner ikke har nogen kraft i sig selv (Jensen, 2009) – men altid må vurderes i kontekst? Og hvad nu hvis man ikke kan overføre elementer, der bedst hører hjemme i en biomedicinsk forskningsverden til psykologiens praksisfelt?

Hvad nu hvis symptomer som motorisk uro, impulsivitet og koncentrationsbesvær kan udspringe af et utal af forskellige biologiske, psykologiske og

relationelle årsager – og det derfor ikke giver særlig god mening at benytte den samme terapeutiske intervention overfor alle disse børn og deres lige så forskellige familier? Og hvad nu hvis virksomme terapeutiske interventioner ikke er noget, man kan tage op af en værktøjskasse, men noget der opstår i det unikke møde mellem en kompetent, nysgerrig, engageret og empatisk terapeut, der kan spore sig ind på individet, familien og konteksten og skabe epistemisk tillid¹² og håb – og som kan tage afsæt i alle disse ting, når der i et samspil med alle involverede parter tilrettelægges en intervention, som er meningsfuld – også for terapeuten selv¹³ – og som kontinuerligt ændrer form, fordi intet i menneskelivet er statisk.

Hvad nu hvis alt det, der er virkningsfuldt i en terapeutisk intervention rummer en kompleksitet og nogle fænomener, som ikke kan forenes med en positivistisk tankegang og et RCT-studie? Hvis vi insisterer på at sætte

12 Epistemisk tillid blev introduceret af Peter Fonagy og hans kollegaer i 2014. Begrebet refererer til en persons tillid til, at den viden, der formidles til ham/hende i en social kontekst, er relevant, ægte og vedkommende.

13 Carsten René Jørgensen, professor i klinisk psykologi og forfatter til bogen “Den psykoterapeutiske holdning” beskriver bl.a., at gode terapeuter har menneskelige kompetencer så som relationsevne, dømmekraft og evne til at etablere kontakt og byde ind med følelsesmæssig afstemning. Han understreger, at det er vigtigt, at psykologer er veluddannede, men at der ikke er noget, der tyder på, at den ene metode er betydeligt bedre end den anden. Det handler om, at finde de metoder, der stemmer overens med egne forforståelser og værdisæt.

noget på formel, som reelt ikke kan sættes på formel, så bliver konklusionen, at der ikke er evidens for effekten. Derved risikerer vi at stå i en situation, hvor det, som bliver fremhævet som en indsats, der er evidens for – reelt set ikke er det mest hjælpsomme for det enkelte barn og den enkelte familie – men blot det, som bedst lader sig måle med det redskab, som vi nu engang har besluttet os for at bruge.

Evidenskravet, som det aktuelt udspiller sig, kan således – sammen med de andre skitserede elementer, og muligvis et par stykker mere, komme til at favorisere den medicinske tilgang – og få andre tilgange til at fremstå som uvidenskabelige og uden effekt. Og det til trods for, at Sundhedsstyrelsen i deres aktuelle retningslinjer for udredning og behandling af ADHD gør opmærksom på, at der reelt ikke er evidens for, at længerevarende medicinering har en positiv effekt.

Så når der ikke er evidens for, at det skulle gavne at medicinere børn med ADHD medicin i længerevarende perioder – og man samtidig ikke kan afvise, at præparaterne kan have langtidsbivirkninger og alvorlige skadevirkninger, så kan man vel regne med, at medicinering forekommer i en tidsbegrænset periode med en stor opmærksomhed på mulige bivirkninger/skadevirkninger – og en konstant søgen efter andre virksomme og uskadelige interventioner? Eller kan man nu også det? Og hvem er det egentlig, som skal træffe beslutning om at afslutte en medicinsk behandling? Er det den ansvarlige læge – eller sygeplejerske? Er det forældrene, som muligvis har forskellige forforståelser, som understøtter en

medicinsk tilgang, eksempelvis at ADHD er en sygdom, som kræver en medicinsk behandling på samme måde, som diabetes kræver insulin? Eller er det muligvis barnet eller den unge selv?

Når nysgerrigheden og tvivlen ikke får plads

Jeg har fulgt Thomas på sidelinjen i 10 år – siden han var 8 år. Han blev diagnosticeret med aspergers syndrom og ADHD, da han var 6 år gammel. Han blev derefter – og i de følgende 11 år – medicineret med forskellige præparater til behandling af ADHD og derudover fik han antipsykotisk medicin. Han var ekstremt lydfølsom, havde mange angstsymptomer, hallucinationer og søvnforstyrrelser igennem sin barndom. Han sov generelt meget dårligt og magtede ofte ikke social kontakt. Han mærkede ikke sult, og var generelt undervægtig og svær at få til at spise. Han var meget ufleksibel og ofte meget træt og initiativløs. Hans stemningsleje var primært neutralt, afbrudt af perioder hvor han blev vred eller oprevet. Han viste meget sjældent tegn på glæde eller begejstring. Han var kvik og klarede sig i de fleste fag rigtig godt. Han fik eksempelvis 12 til sin 9. klasses eksamen i matematik og engelsk. Thomas tilbragte det meste af sin fritid på sit værelse foran sin computer med onlinespil. Da han var 14 år gammel overvejede forældrene at køre ham på psykiatrisk skadestue, da han i perioder isolerede sig helt på sit værelse og havde voldsomme reaktioner, hvis man forsøgte at etablere kontakt til ham. Han virkede ofte trist, forvirret og modløs.

Thomas' far kontaktede i perioden psykiatrien med en række spørgsmål. Han var bekymret for sønnens generelle trivsel, som han i en årrække havde oplevet som nedadgående. Han gjorde opmærksom på, at han så et sammenfald imellem mange af de vanskeligheder, som Thomas havde – og de bivirkninger som var beskrevet som "meget almindelige" og "almindelige" i forhold til den medicin Thomas tog. Han bad bl.a. psykiatrien forholde sig til, om de fortsat tænkte, at det var gavnligt for Thomas at være medicineret. Forældrene blev på et efterfølgende møde informeret om, at Thomas kunne holde en pause fra medicinen, hvis forældrene ønskede det. De blev også informeret om, at han ikke ville opleve nogen abstinenssymptomer, såfremt de afbrød den medicinske behandling, eftersom al medicin ville være ude af kroppen på 24 timer. Da forældrene stoppede med medicinen oplevede de i de følgende døgn så voldsom en forværring i Thomas' tilstand, at de besluttede sig for at give ham medicinen igen. Thomas påbegyndte nogle måneder efter under protest i 10. klasse et efterskoleophold med ekstra støtte.

Efter ½ år på efterskolen var forandringen med Thomas mærkbar for omgivelserne. Han havde nu et socialt liv med venner, han også besøgte i fritiden, og han var begyndt at udvise interesse for sit eget liv. Han udviklede i løbet af de 2 år, han gik på efterskolen en stor interesse for musik og begyndte at spille et instrument. Han stoppede stort set med at spille computer. Han blev mere opmærksom på sin egen krop og betydningen af at være fysisk

aktiv. Han begyndte eksempelvis at gå lange ture og løbe.

Da han var 17½ år gammel valgte han på eget initiativ at stoppe med at tage medicin. I den forbindelse indvilligede han i at svare mig skriftligt på en række spørgsmål, der omhandlede hans oplevelse af sin beslutning og den årelange kontakt med psykiatrien.

Om beslutningen skrev Thomas bl.a.:

"Jeg følte mig lænket og afhængig, jeg følte mig som en kopi af mig selv. Og nu da mine abstinenser er overståede, føler jeg mig endnu mere fri end nogensinde"... "Jeg følte vel bare ikke, at jeg var mig selv, og jeg ville ikke være afhængig af en pille resten af livet. Så jeg ofrede koncentrations-evenen for at føle mig som mig".

Thomas beskrev, at det helt og holdent var hans egen beslutning at stoppe med medicinen, men at psykiatrien havde bakket op om beslutningen, da han havde meddelt det. Sygeplejersken havde supplerende sagt til ham, at han jo kunne benytte medicinen igen, hvis han havde svært ved at koncentrere sig i forbindelse med eksamenerne. Thomas beskrev videre, at han aldrig var blevet informeret om bivirkningerne af medicinen i børne- eller ungdomspsykiatrien eller informeret om abstinenssymptomer, da han stoppede:

"Ungdomspsykiatrien har en tankegang, der tyder på, at de tror, der ikke er bivirkninger eller abstinenser. De mente, at man bare kunne stoppe uden videre, hvor jeg sagde: 'Det kan man ikke. Jeg har absti-

nenser, når jeg vågner om morgenen, og de hører op, når jeg tager medicinen.”

Thomas beskrev, at han havde det, han kalder abstinenssymptomer op til 40 dage efter, han var stoppet med medicinen. De første 14 dage, var symptomerne meget intense og aftog derefter. Han beskrev sine abstinenssymptomer således:

“Hjertebanken: Mit hjerte bankede højlydt og hurtigt i mange uger efter, jeg stoppede.

Intens indre uro: Jeg var fuldstændig grædefærdig over at have så meget uro inde i mig. Det føltes som om jeg ville sprænge i luften når som helst.

Fysisk ukomfortabel: Uanset hvilken position min krop var i, eller hvor meget jeg havde spist/drukket, var min krop aldrig “tilfreds”. Det er en følelse, der ikke kan beskrives, men skal føles. Det tætteste, jeg kan komme på det, er med ordene “fysisk ukomfortabel”. Meget ubehagelig fysisk følelse.

Koldsved: Jeg frøs og svedte samtidig.

Depression: Jeg var dybt demotiveret og trist, ligeglad med alt, hver dag føltes som ingenting.

Intens træthed, mentalt og fysisk.”

Thomas beskriver, at han har oplevet store ændringer på en række områder,

efter han ikke længere er medicineret, og han er kommet over abstinenssymptomerne. De største ændringer er ift. søvn, appetit, aktivitetsniveau/koncentrationsevne og humør. Han beskriver det således:

– Søvn: Jeg sover langt bedre, og har nu en døgnrytme, hvor jeg bliver naturligt træt. Det gør også, at jeg ikke længere har brug for Quetiapin, som var det andet antipsykotika, jeg tog.

– Appetit: Jeg spiser betydeligt mere nu, hvor jeg er umedicineret; derudover mærker jeg sult, hvilket er en ny følelse, jeg stadig skal vænne mig til. Før spiste jeg kun, hvis jeg fik besked på det, eller min mave rumlede, det var dét, der var “sult” for mig. Men nu kan jeg mærke, når kroppen siger, at den vil have mad. Det er en underlig følelse.

– Humør: Jeg er generelt betydeligt gladere, end jeg nogensinde har været, og jeg kan opretholde et godt humør, selv når jeg ikke har spist. Det plejede jeg ikke at kunne. Jeg har stadig humørsvingninger en gang imellem, hvor jeg pludselig bliver demotiveret og trist, men sådan har det altid været.

– Koncentrationsbesvær: Jeg har svært ved at koncentrere mig om indviklede logiske opgaver, primært matematik.... Nu er jeg fx, i matematik, nødt til at skrive alt ned når jeg løser opgaver, hvor jeg før i tiden kunne have alle mine mellemregninger i hovedet. Til gengæld føler jeg, at jeg er meget mere klarttænkende

og motiveret, når det kommer til abstrakte opgaver, som at skrive en stil eller svare på en mail. Derudover er jeg mere koncentreret om fysiske opgaver.

Thomas beskriver, at han generelt ser det som noget positivt at have fået mere energi, og at han nu er mere vedholdende, når han skal deltage i praktiske og fysiske aktiviteter. Hans tolerance overfor lydstimuli er også blevet hævet betydeligt. Thomas spiser nu sammen med andre mennesker, deltager i familiefester og går til rockkoncerter – ting som ikke var muligt for ham tidligere. Thomas' familie oplever samstemmende med Thomas' egen beskrivelse en ung mand med et helt andet funktionsniveau, efter han ikke længere er medicineret. Han er nu generelt glad, aktiv og social og udviser et meget større overskud i dagligdagen. Thomas har påbegyndt en gymnasial uddannelse, han har fået en kæreste, og han klarer sig fortsat rigtig godt fagligt.

Thomas' historie og beskrivelse kan ikke sige noget generelt om, hvordan det er at være diagnosticeret med psykiske lidelser og medicineret med psykofarmaka – den er en enkeltstående casebeskrivelse. Men som en enkeltstående casebeskrivelse kan – eller i dette tilfælde – bør den give anledning til, at der stilles spørgsmålstejn ved etablerede forforståelser og til refleksion på mange niveauer. Refleksioner som: Har vi i tilstrækkelig grad øje for konsekvenserne af en biomedicinsk diskurs – og er vi i tilstrækkelig grad uærbødige og kritiske overfor den? Hvad er konsekvensen, når vi glemmer at se på hel-

heden og sammenhængene – altings forbundethed – når vi bliver for optagede af at løse nogle vanskeligheder og overser, at vi i processen får skabt en stribe andre? Hvilken betydning fik det for Thomas' udviklingsmuligheder, at han skiftede miljø og fik chance for at skrive en ny livshistorie, at han blev mødt med nye forventninger, at han blev et vellidt og forpligtet medlem af et off-line fællesskab, og at han blev fysisk aktiv? At han således oplevede anderledes og udviklingsfremmende fysiske/biologiske, psykologiske og sociale input i en kritisk livsperiode.

Det tilstrækkeligt gode børneliv?

Der er mange advarselsslamper – ikke kun i Thomas' og Christians historier – men i historierne fra alle de børn og unge som mistrives i samfundet i dag. Antallet af børn, der er i kontakt med psykiatrien, er mangedoblet over en 10-20-årig periode¹⁴. Den foretrukne forklaring på al den lidelse bliver ofte, at der er noget galt med det pågældende barn – eksempelvis at det har en neurobiologisk defekt. Den forklaring hviler på en præmis om, at de udviklingsvilkår, vi i dag tilbyder børn og unge, er tilstrækkeligt gode – og således burde resultere i trivsel og ensartet udvikling. Men er den præmis gyldig?

14 Blandt børn og unge er ADHD den hyppigst registrerede psykiske diagnose – og den som har været i størst vækst. I 2001 var der ca. 1.000 børn og unge med diagnosen. I 2011 var tallet steget til ca. 8.000. Kilde: AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI: "Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser – udvikling i diagnoser og behandling" fra oktober 2013.

Der er de sidste 10-15 år sket mange ting samfundsmæssigt, som kan skabe uro i et børneliv. Vores børnesyn er på flere afgørende områder ændret – og har således skabt et pres på selv helt små børn, som de tidligere var forskånet for. Børn tilbringer generelt mange timer i daginstitution. Disse timer går i dag i høj grad med at erhverve kompetencer, som de skal bruge i voksenlivet for at blive produktive medlemmer af konkurrencestaten. Vi vægter i højere grad instruktionspædagogik og tidlig kognitiv træning. Kravene til de små formuleres i stigende grad af økonomer, jurister og politologer – faggrupper som mangler viden om små børn og skoleelevers læring, udvikling og dannelse (Sommer, 2017). Vi måler og dokumenterer børns kompetencer og udvikling som aldrig før med det formål at sikre, at vi som fagpersoner hurtigt kan sætte ind med en målrettet indsats, såfremt der er tegn på, at de sakker bagud. Den tid, pædagogerne bruger på disse aktiviteter, går fra den sociale kontakt med børnene – derudover er der pga. nedskæringer, i samme periode som dokumentationskravene er steget, kommet færre voksenhænder- og hjerter i institutionerne. Det er nærliggende at tænke, at en del børn oplever lange dage med fortravlede voksne, som mangler den fornødne tid til at se, rumme, spejle, anerkende, hjælpe og mentalisere. Det er også nærliggende at tænke, at en del af de børn bliver hentet af stressede forældre¹⁵, som kan have svært ved at hånd-

tere de krav om kontakt, tydelighed og lydhørhed, som børnene stiller. Løsningsen bliver måske ofte en iPad. I den digitale verden er barnelivet fyldt med stimuli og valg. Barnet er i dag blevet en forbruger, hvilket bevirker at der er kamp om barnets opmærksomhed – også hos de helt små. Den digitale verdens insisteren på opmærksomhed er mistænkt for at berøve børn kostbar nattesøvn¹⁶ og kostbar tid, som man tidligere brugte på at opøve mangedannede kompetencer. Det er således ikke umuligt at mange (små)børn i dag lever et liv med utilstrækkelig voksenkontakt, for høje kognitive krav, for lidt søvn, for mange stimuli og for lidt tid til at øve sig i at være menneske. Ved skolealderen møder børnene for alvor det snævre normalitetsbegreb, som vi opererer med i dag og den manglende tålmodighed med børns forskellige udviklingstempi. Dette normalitetsbegreb og den begrænsede tålmodighed er bl.a. affødt af det store fokus på den boglige uddannelse sammen med de begrænsede ressourcer i systemet. Budskabet bliver derfor: Hvis du ikke kan sidde ned og være undervisningsparat og koncentreret i mange timer i en klasse med op til 28 elever, så er du afvigende. Vi vægter som samfund en bestemt type kompetencer så højt, at vi gør dem, som har andre kompetencer, forkerte. Vi har ikke længere tolerance overfor, at mennesker er forskellige. Samtidig med at vi ophøjer evnen til vedvarende koncentration – udsætter

15 Den Nationale Sundhedsprofil viser, at andelen af danskere med et højt stressniveau var på 25,1 % i 2017.

16 Se eksempelvis Center for Børnelivs "Hvad ved vi om børn og unges søvn", der refererer til forskellig forskning der viser, at mange børn i dag sover for lidt.

vi børn og unge for en verden fyldt med aktiviteter, der er mistænkt for at forstyrre evnen til vedvarende opmærksomhed og for dybelse – og på anden vis skabe mistrivsel¹⁷.

Når vi i dag vælger at zoome ind på det enkelte barn(s neurobiologi), overser vi alle de komplekse sammenhænge som på forskelligartede måder og på forskellige niveauer påvirker et barns mulighed for trivsel og udvikling – også neurobiologisk udvikling. Og vi glemmer at sætte spørgsmålstejn ved vores eget bidrag. Er det eksempelvis hjælpsomt, når vi som fagpersoner, laver problemættede beskrivelser i lange rapporter eller tildeler diagnoser, som kan risikere at blive selvopfyldende profetier? Eller ville det være meget mere hjælpsomt, hvis vi gjorde noget helt andet? Hvis alle gjorde noget helt andet.

Behovet for en ny tilgang

Jeg oplever, at vi aktuelt ignorerer den viden, som vi har om, hvad der skaber børn i trivsel¹⁸. At børn har behov for sensitive omsorgspersoner, der er nærværende og følelsesmæssigt tilgængelige. At børn har behov for øjenkontakt, berøring og spejling. At relationelle

faktorer påvirker hjernens udvikling. Vi overser betydningen af at være et værdsat medlem af et fællesskab og muligheden for at kunne få følelsesmæssig støtte. Vi glemmer vigtigheden af at blive mødt med positive forventninger, tiltro til at man gør sit bedste og tillid til at alt det, som er svært, kan komme til at se anderledes ud. Vi glemmer, at børn er biologiske væsener, der har behov for fysisk aktivitet for at trives både fysisk og mentalt.

Når vi zoomer ind på neurobiologien, glemmer vi at koble vores viden om børns behov med deres reelle muligheder for at få dækket disse behov i deres liv i dag. Dette reducerede fokus har omkostninger – både for det enkelte barn og den enkelte familie, men også for de forskellige sammenhænge, vi alle er en del af.

De mangeartede udfordringer, vi i dag står overfor, kalder på en ny tilgang. Uagtet om det handler om stigningen i psykiatriske lidelser, stigningen i tilfælde af diabetes 2 eller klimakrisen, så er der behov for, at vi bevæger os væk fra det reducerede fokus og de enkle løsninger. Det er nødvendigt og presserende, at vi interesserer os for altings forbundethed – og således i langt højere grad har øje for de større sammenhænge. Det bliver eksempelvis meningsløst at konkludere, at der ikke er evidens for at sige, at det er skadeligt for børn og unge, at de i dag tilbringer væsentligt mere tid foran skærme – når forekomsten af overvægt som bl.a. er et resultat af fysisk inaktivitet, er et gigantisk og stigende sundhedsmæssigt problem på verdens-

17 Manfred Spitzer, psykiater og forfatter til bogen "Digital Demens" og Jean Twenge, psykologi professor, forsker i generationsforskelle og forfatter til bogen "iGen" er blandt de fagpersoner, der udtrykker bekymring for, hvordan den digitale udvikling, sociale medier og de mange timer foran skærme påvirker børn og unges trivsel og udviklingsmuligheder.

18 Der refereres her til viden fra mange forskellige kilder, eksempelvis Harry Frederic Harlow, René Spitz, Donald Winnicott, Daniel Stern, Edward Tronick, Peter Fonagy og Søren Hertz.

plan¹⁹. Der er i dag behov for, at vi forholder os meget mere kritisk til evidensbegrebet og eksempelvis stiller spørgsmålstejn ved, hvornår det giver mening at afklare, om der er evidens for noget²⁰ – og hvornår det ikke giver mening. At der ikke er evidens for, at noget er skadeligt – er ikke det samme som, at det er ufarligt eller gavnligt. Det er måske i højere grad et udtryk for den aktuelle forsknings begrænsninger. Dette bør være meget mere synligt.

ADHD området er her blevet brugt til både at illustrere nogle generelle problematikker i samfundet i dag, eksempelvis konsekvenserne af et reducerende fokus, men også nogle mere specifikke problematikker, eksempelvis konsekvenserne af en medicinsk behandlingstilgang.

Ift. ADHD området kunne jeg ønske mig, at der blev plads til meget mere tvivl og usikkerhed, så tilgangen på området i højere grad afspejlede vores aktuelle/reelle viden – og ikke kun den viden, vi har valgt at give forrang. Derudover ligger hele området op til en drøftelse af hvilke værdier og hvilket menneskesyn, vi ønsker at vægte i vores samfund. Er det eksempelvis vigtigere, at børn kan komme hurtigt igennem skolesystemet og forholde sig i ro – end at de får tilstrækkeligt med mad, søvn og livsglæde? Skal vi opfordre dem til at tage medicin i forbindelse med eksamener, så de kan præstere til et 12 tal – eller skal vi acceptere mid-

delmådighed? Kan/skal vi behandle os ud af impulsivitet og ikke optimale koncentrationsevner – eller er dette en naturlig del af det menneskelige spektrum? Dette er en vigtig samfundsdebat.

I dag er der ift. ADHD et stort fokus på, om en behandling/intervention afhjælper kernesymptomerne på gruppeniveau – og der er som illustreret en præference for den medicinske behandlingstilgang. Pga. den store alvor, der er forbundet med at medicinere børn og unge med psykofarmaka, burde der i langt højere grad være et krav om fortløbende og systematisk dokumentation for, at en sådan behandling er nødvendig og gavnlig for det konkrete barn. Ses der efter en igangsat behandling eksempelvis tegn på reduceret lidelse, større trivsel og bedre udviklingsmuligheder – og hvordan? Har vi forholdt os til eventuelle bivirkninger og gjort vores ypperste for at sikre, at disse ikke overstiger fordelene ved medicinen? Har vi sikret, at vi ikke blot får skabt nye problemer for barnet (familien og samfundet), som vi så forsøger at afhjælpe med anden og mere medicin? Derudover burde der være en forpligtelse til med omhu at forholde sig til hele barnets livssituation og reelle udviklingsbetingelser både i en udredningssituation og ved en behandlingsindsats. Det burde eksempelvis ikke være muligt, at diagnosticere og medicinere børn uden at barnet først er observeret i alle dets centrale kontekster – både i hjemmet og i skole/institution i samspil med de betydningsfulde voksne og andre børn. Mistrivsel må ikke blive et individuelt anliggende – det skal forstås i sammenhæng. Der-

19 Se bl.a. videnskab.dk "Hver tredje person i verden er overvægtig" fra 24. juli 2014

20 Med udgangspunkt i den aktuelle (foretrukne) forståelse af evidens og evidenshierarkiet.

med bør der også være en langt større forpligtelse til at løfte behandlingen væk fra individet – og se på rammer, relationer og livsbetingelser i vores tilgang. Ofte er der et alt for stort fokus på kompenserende strategier, som kan afhjælpe problemer – og et alt for lille fokus på, hvad der skaber trivsel og udvikling hos børn.

På ADHD området er der, som på mange andre områder i dag, behov for at vi tør være mere nysgerrige og meget mere i tvivl. Der er behov for, at vi tør sætte spørgsmålstejn ved de etablerede forforståelser og de endegyldige konklusioner – og at vi tør være meget mere insisterende på, at vi skal forholde os til kompleksiteten og de større sammenhænge. Dette er vigtigt, både for det enkelte barn og den enkelte familie – men også som illustreret i en meget større sammenhæng.

Referencer

- Bateson, N. (2010). *An Ecology of Mind*. Dokumentarfilm
- Bateson, N. (2016). *Small Arcs of Larger Circles – framing through other patterns*. Axminster, England. Triarchy Press
- Bateson, N. (2017). *Warm Data. Contextual Research and New forms of Information*. Udgivet på *hackernoon.com* 28. maj 2017.
- Ekeland, T.-J. (2009). Hva er evidensen for evidensbasert praksis? *Evidensbasert Profesjonsutøvelse. Kap. 8*. 145-167
- Gundersen, L., Hertz, S. og Nielsen, J. (2016). Et indlæg i den nødvendige debat om tidlig indsats. *P-Psykologernes Fagmagasin*
- Harris, N. B. (2014). How Childhood Trauma affects Health across a Lifetime. *TEDMED – Foredrag offentliggjort på YouTube 2015*
- Hertz, S. (2008). *Børne- og ungdomspsykiatri*. København. Akademisk Forlag
- Hertz, S. (2015). Social uorden bliver gjort til individuel uorden. *Udsatte børn og unge – en grundbog. Kap. 17*. Hans Reitzels Forlag
- Hertz, S. (2017). *Børn og unge, psykiatri og samfund*. København. Akademisk Forlag
- Hoffmann, T. (2019). Skal vi kalde "klimaforandringer" for klimakrise? *Videnskab.dk*
- Jensen, P. (2009). Virkningsdiskursen. *Fokus vol. 37*. 194-201
- Montuori, A. (2005) Gregory Bateson and the Promise of Transdisciplinarity. *Cybernetics And Human Knowing vol. 12*. 147-158
- Mosgaard, J. (2009). Sprogets forelæser. Om diagnoser og andre konklusioner. *Fokus vol. 37*. 238-255
- Nielsen, J. & Hertz, S. (2010). Den foretrukne viden. *Psykolog Nyt nr. 18*. 20-24
- Rockwoolfonden (2014). ADHD koster ubehandlet knap 3 mia. kroner om året. *Nyt fra Rockwoolfondens forskningsenhed*
- Sommer, D. (2017). Udvikling. Fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab. *Samfundslitteratur*. 79-105
- Sundhedsstyrelsen (2017). Prævalens, incidens og aktivitet i sundhedsvæsenet for børn og unge med angst eller depression, ADHD og spiseforstyrrelser.
- Sundhedsstyrelsen (2018). Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge. National klinisk retningslinje.
- Thorgård, K. (2012). Evidensbevægelsen – en bevægelse i konflikt med sig selv. *Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift nr. 3*. 151-158.
- Thurén, T. (2010). Videnskabsteori for begyndere. Rosinante
- Warming, H. (2015). Gør evidens mere skade end gavn? *Social Kritik vol. 43*. 6-13
- WHO (2016). WHO: The International Classification of Diseases. (Film -offentliggjort d. 11. oktober 2016 på YouTube)
- Wilson, J. (2012). A social relational critique of the biomedical definition and treatment of ADHD. Ethical, practical and political implications. *Journal of Family Therapy*.
- Ørum-Madsen, M. S. (2015). Epigenetikken styrer vores DNA's opførsel. *Videnskab.dk*